

CAPÍTULO 14.26

Enfermedad de Kawasaki

PERFIL EUNACOM 1.14.26

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción

La **Enfermedad de Kawasaki** es una vasculitis de medianos y pequeños vasos cuya importancia radica en su capacidad de generar **daño coronario**. Es una patología prevenible y evitable siempre que el médico realice un diagnóstico precoz basado puramente en la **clínica**.

Aunque su etiología exacta es desconocida, se asocia fuertemente a una respuesta inflamatoria gatillada por infecciones virales. Esta teoría se ha reforzado con la pandemia de **COVID-19**, donde el **Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (PIMS/SIM-P)** ha mostrado una fisiopatología y manejo muy similares.

- **Epidemiología:** Afecta principalmente a niños **menores de 5 años**, aunque puede presentarse en edades mayores.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: Se cree que un agente infeccioso (virus) desencadena una respuesta inmunitaria aberrante en individuos genéticamente predispuestos, resultando en una inflamación sistémica de las paredes arteriales, con especial predilección por las arterias coronarias.

Criterios Clínicos para el Diagnóstico

El diagnóstico de la Enfermedad de Kawasaki es **clínico**. El síntoma cardinal y obligatorio es la **fiebre alta y persistente**.

1. Síntoma Cardinal

- **Fiebre mayor o igual a 5 días:** Habitualmente superior a 38.5°C-39°C y que no cede fácilmente con antipiréticos comunes.

2. Criterios Adicionales (4 de 5)

Para completar el diagnóstico, se deben cumplir al menos 4 de los siguientes 5 criterios clínicos:

TABLA 14.26.1: CRITERIO VS DESCRIPCIÓN CLÍNICA

CRITERIO	DESCRIPCIÓN CLÍNICA
Ojo Rojo	Inyección conjuntival bulbar bilateral, no exudativa (sin secreción).
Boca Roja	Labios eritematosos, partidos o fisurados; lengua "en fresa" (roja y papilada); eritema faríngeo.
Adenopatía	Adenopatía cervical, generalmente unilateral, mayor a 1.5 cm de diámetro.
Exantema	Exantema polimorfo (maculopapular, eritematoso). Nunca debe ser vesicular ni pustular.
Manos y Pies	Eritema o edema de palmas y plantas en fase aguda; descamación periungueal en fase subaguda.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Mnemotecnia EUNACOM: Recuerda que en Kawasaki "todo es rojo": - Ojos rojos. - Boca roja. - Ganglios (rojos/inflamados). - Piel roja (exantema). - Manos y pies rojos.

Diagnóstico y Ecocardiografía

Si un paciente tiene 4 días de fiebre pero cumple todos los demás criterios, se suele manejar como un Kawasaki debido al alto riesgo.

- El rol de la **ecocardiografía** varía según la presentación:
- **Kawasaki Clásico:** Se utiliza principalmente para el **pronóstico**. Permite detectar la presencia de **aneurismas coronarios**, lo cual aumenta drásticamente el riesgo de un **Infarto Agudo al Miocardio** a mediano y largo plazo.

- **Kawasaki Incompleto:** En casos donde el paciente no cumple los 4/5 criterios (por ejemplo, tiene fiebre de 5 días pero solo 2 criterios), el ecocardiograma se convierte en una **herramienta diagnóstica**. Si muestra alteraciones coronarias, se confirma el cuadro.

Relación con COVID-19: PIMS / SIM-P

- El **Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (PIMS)** es una complicación post-infecciosa de la COVID-19 que puede manifestarse de diversas formas:
- **Fenotipo Kawasaki:** Idéntico a la enfermedad de Kawasaki clásica.
- **Fenotipo de Compromiso General:** Fiebre alta asociada a shock (hipovolémico o vasodilatador).
- **Fenotipo Gastrointestinal/Miocárdico:** Dolor abdominal intenso, diarrea y cuadros de miocarditis aguda.

El diagnóstico diferencial depende del antecedente de infección por SARS-CoV-2 en el mes previo.

Tratamiento

El objetivo principal del tratamiento es **prevenir el daño coronario**. Si se administra oportunamente, la mayoría de los niños se recupera sin secuelas.

- **Inmunoglobulina G Endovenosa (IGIV):** Es el pilar fundamental. Se administra en dosis altas para frenar la cascada inflamatoria.
- **Aspirina (Ácido Acetilsalicílico):** Se utiliza por su efecto antiinflamatorio (en dosis altas inicialmente) y antiagregante (en dosis bajas posteriormente) para proteger las coronarias.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El diagnóstico tardío o la falta de tratamiento con inmunoglobulina aumenta significativamente el riesgo de que el niño desarrolle aneurismas y fallezca años después por un infarto miocárdico.

Complicaciones y Otros Hallazgos

Complicaciones Graves

- **Miocarditis Aguda:** Es la causa más frecuente de **muerte en la fase aguda**. Puede presentarse con **Insuficiencia Cardíaca**, shock cardiogénico o edema pulmonar agudo. - **Aneurismas Coronarios:** Principal secuela a largo plazo que predispone a trombosis e infartos.

Hallazgos de Laboratorio y Signos Asociados

Además de los criterios diagnósticos, existen otros hallazgos clínicos y de laboratorio que orientan la sospecha:

- **Piuria Aséptica:** Presencia de leucocitos en la orina sin bacterias.
- - *Error común:* Confundir el cuadro con una Infección Urinaria (ITU). Si el paciente recibe antibióticos y luego desarrolla el exantema, se puede pensar erróneamente en una alergia a fármacos.
- **BCGitis:** Inflamación, eritema o reactivación en el sitio de la cicatriz de la vacuna BCG. Es un signo muy específico de Kawasaki.
- **Alteraciones en el Hemograma:**
- - Anemia normocítica normocrómica (de enfermedades crónicas/inflamatorias).
- - **Trombocitosis reactiva:** Elevación importante de las plaquetas, generalmente en la segunda semana de evolución.

NOTA CLÍNICA

La **BCGitis** es un hallazgo clínico de gran valor diagnóstico en lactantes chilenos, dada la vacunación universal. Si ves una cicatriz de BCG inflamada en un niño con fiebre, piensa inmediatamente en Kawasaki.

Resumen para el EUNACOM

- **Fiebre ≥ 5 días** es el requisito base.
- El diagnóstico es **clínico** (4 de 5 criterios de "rojez").
- El tratamiento con **Inmunoglobulina IV** debe ser precoz para evitar aneurismas.
- La **Ecocardiografía** busca complicaciones coronarias.
- La **Miocarditis** mata en el periodo agudo; el **Infarto** (por aneurismas) mata en el periodo crónico.
- Ante un cuadro de shock o compromiso gastrointestinal post-COVID, sospechar **PIMS**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 3 años con 6 días de fiebre alta, conjuntivitis bilateral, labios rojos y fisurados, exantema maculopapular y edema de manos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Enfermedad de Kawasaki. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Vasculitis pediátrica (<5 años) con daño coronario prevenible
- Diagnóstico: fiebre ≥ 5 días + 4 de 5 criterios (ojo rojo, boca roja, adenopatías cervicales, exantema, afectación manos/pies)
- Ecocardiograma: pronóstico en la mayoría, diagnóstico en cuadros incompletos
- Tratamiento: inmunoglobulina G endovenosa + aspirina (previene daño coronario)
- Miocarditis aguda: causa de muerte en agudo; daño coronario: causa de muerte a largo plazo
- Si COVID-19 reciente: diagnóstico es síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS)
- Piuria aséptica puede confundir con ITU; BCGitis es signo asociado

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ENFERMEDAD DE KAWASAKI)

PREGUNTA 1

Niño de 3 años con 6 días de fiebre alta, conjuntivitis bilateral, labios rojos y fisurados, exantema maculopapular y edema de manos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Escarlatina
- B)** Sarampión
- C)** Enfermedad de Kawasaki
- D)** Mononucleosis infecciosa
- E)** Artritis juvenil idiopática sistémica

PREGUNTA 2

¿Cuál es el tratamiento de primera línea de la enfermedad de Kawasaki y cuál es su objetivo principal?

- A)** Corticoides endovenosos para controlar la fiebre
- B)** Antibióticos de amplio espectro para la infección
- C)** Inmunoglobulina G endovenosa para prevenir el daño coronario
- D)** AINEs para la inflamación articular
- E)** Metotrexato para la vasculitis

PREGUNTA 3

¿Cuál es la causa de muerte en la fase aguda de la enfermedad de Kawasaki?

- A)** Aneurisma coronario con infarto
- B)** Insuficiencia renal
- C)** Miocarditis aguda
- D)** Meningitis
- E)** Hemorragia pulmonar

RESUMEN: ENFERMEDAD DE KAWASAKI

La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis pediátrica (habitualmente menores de 5 años) cuya importancia radica en el daño coronario prevenible. Su etiología es desconocida, probablemente asociada a infecciones virales (reforzado por el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19). El diagnóstico es clínico: fiebre mayor o igual a 5 días más al menos 4 de 5 criterios (ojo rojo, boca roja, adenopatías cervicales, exantema no vesicular ni pustular, y afectación de manos/pies con eritema, edema o descamación). El ecocardiograma sirve para el pronóstico (buscar aneurisma coronario) y es diagnóstico en cuadros incompletos. Si hubo COVID-19 en el último mes, el diagnóstico es síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS). El tratamiento es inmunoglobulina G endovenosa más aspirina, que dado oportunamente previene el daño coronario. En agudo puede complicarse con miocarditis (causa de muerte aguda), piuria aséptica, BCGitis, anemia normocítica normocrómica y trombocitosis reactiva.